

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA COLUMBIA PARA EVALUAR EL RIESGO DE SUICIDIO

(Columbia-Suicide Severity Rating Scale — C-SSRS Screener / Triage Clínico)

Posner, K., et al. (2011). *Am J Psychiatry*, 168(12), 1266-1277. • Versión en español oficial.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	N° H.C. / Cód.:

REGLA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA DEL C-SSRS: Haga siempre las preguntas **1 y 2**. Si ambas son «NO», pase directamente a la **Sección II: Comportamiento Suicida**. Si la pregunta **2 es «SÍ»**, formule obligatoriamente las preguntas **3, 4 y 5**. Si la pregunta 1 o 2 es «SÍ», complete la evaluación de intensidad.

N°	SECCIÓN I: IDEACIÓN SUICIDA	Toda la vi- da	Último mes
1	Deseo de estar muerto(a): ¿Ha deseado estar muerto(a), no despertar o desear quedarse dormido(a) y no despertar jamás?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
2	Pensamientos suicidas activos no específicos (sin método ni plan): ¿Ha tenido pensamientos de matarse o quitarse la vida (sin pensar en una forma concreta de hacerlo)?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
3	Pensamientos suicidas con métodos (sin plan ni intención específica de actuar): ¿Ha pensado en cómo podría matarse (p. ej., pastillas, tirarse de un lugar, ahorcarse), pero sin intención de hacerlo?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
4	Intención suicida activa (con cierta intención de actuar, sin plan detallado): ¿Ha tenido pensamientos de matarse y ha tenido alguna intención o impulso de llevarlos a cabo?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
5	Plan e intención suicida activa: ¿Ha empezado a elaborar o ya ha elaborado un plan específico para suicidarse? ¿Tenía la intención de realizarlo?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

N°	SECCIÓN II: COMPORTAMIENTO SUICIDA	Toda la vida	Últimos 3 m.
6	Intento real de suicidio: ¿Hizo alguna vez algo para hacerse daño o quitarse la vida intencionadamente (incluso si no provocó lesiones graves)? <i>Si no tenía ninguna intención de morir (solo aliviar dolor o comunicar angustia), marque Autolesión No Suicida.</i>	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
7	Intento interrumpido: ¿Comenzó a hacer algo para matarse, pero alguien o algo lo detuvo antes de que se hiciera daño? (P. ej., tenía la soga o el frasco en la mano y alguien se lo quitó).	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
8	Intento abortado / voluntariamente detenido: ¿Comenzó a hacer algo para matarse, pero usted mismo(a) se detuvo antes de causarse daño alguno?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
9	Conductas o actos preparatorios: ¿Ha tomado medidas para prepararse para suicidarse? (P. ej., escribir cartas de despedida, regalar posesiones valiosas, acumular pastillas, conseguir un arma o cuerda).	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y PROTOCOLO DE TRIAJE (C-SSRS):

RIESGO BAJO (VERDE) · Solo respuesta afirmativa a **ítem 1 o 2.** · **Acción:** Derivación rutinaria a salud mental; entregar números de atención en crisis y psicoeducación.

RIESGO MODERADO (AMARILLO) · Respuesta afirmativa a **ítem 3** o conducta suicida ocurrida hace más de 3 meses. · **Acción:** Evaluación médica/psiquiátrica prioritaria; plan de seguridad formal y apoyo familiar.

RIESGO ALTO (ROJO) · Respuesta afirmativa a **ítem 4 o 5, o cualquier conducta suicida en los últimos 3 meses.** · **Acción INMEDIATA:** No dejar sola a la persona; activar observación 1 a 1 y trasladar urgente a guardia psiquiátrica.

psico-flujo · Escala oficial C-SSRS Screener / Triaje Clínico (Posner et al., 2011). Uso libre para detección y prevención del suicidio.